



FICHA DE INGRESO PSIQUIATRÍA INFANTO-JUVENIL

Conforme a normativa chilena – Uso Clínico

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

- Nombre: Santiago Carrasco Nuñez
- RUN: 23.010.127-2
- Fecha de nacimiento: 4 mayo
- Edad: 16 años
- Sexo: masculino
- Escolaridad: 3° medio
- Establecimiento educacional: Liceo Alemán Paine
- Nombre del cuidador/tutor legal: vive con padre Mario Carrasco
- Contacto: carrasco.mario.1978@gmail.com

2. MOTIVO DE CONSULTA

- Descripción del motivo de consulta: ideas de autodaño en enero 2026, psicóloga sugiere ser evaluado por psiquiatra
- Tiempo de evolución:
Padres refieren que Santiago habría referido ideas de autodaño el 2023 y luego en enero de 2026 (cortarse con un cuchillo o enterrarse un cuchillo), sin llegar en ninguna ocasión a concretarlo. Tiene una psicólogo que lo ve de manera esporádica, no han podido adherir de manera adecuada. Padre refiere notarlo de mas bajo animo desde hace 3 años: tiende a aislarse, se observa desmotivado, le gusta estar en caso, no sale mucho. Actualmente vive junto a padre y hermana Amanda de 15 años. Madre vive con Colina padres se separan el 2017 en no buenos términos. Nunca antes habrían consultado con psiquiatra.

A entrevista con Santiago solo: refiere inicia ideas de autodaño por primera vez a los 14 años, dice fue de manera brusca mientras jugaba videojuegos, sin desencadenante aparentemente. Luego en enero idea nuevamente aparece de manera brusca, dura 2 horas, logra distraerse, luego idea desaparece. Aparecen luego idea de manera intermitente pero leve, fugaz, no llega a concretarlo. Refiere en enero se asocio a ideación suicida, pero esta no persiste en el tiempo. Si notaba en época de verano días de poco animo, a veces triste, a veces ganas de llorar, pero no de manera marcada. Le cuesta describir y reconocer sus estados emocionales. Se indaga en animó hoy: niega pena o tristeza, niega ideas de autodaño, niega ideación suicida.

Intereses: estar con sus amigos, jugar videojuegos. Si bien reconoce pocas habilidades sociales y refiere decir que a veces la gente lo cansa o estresa (no le gusta el ruido, a veces desea estar solo), tiene grupo de pares con quien se siente a gusto, también pareja desde hace 4 meses. A nivel académico va bien, le gusta matemáticas. El año pasado riesgo de repetir por inasistencia, le costaba levantarse, poca energía, desmotivación. Se indaga en experiencias adversas en infancia:

-6 años bullying

-6-7 años sensación de abandono de parte de padres, lo describe como "momentos de abandono"

-6-7 años testigo discusiones de padres y separación de estos

-hace 3 años decide vivir con padre y madre llama diciendo que los va a secuestrar y que llamara a carabineros por irse con padre.

Actualmente refiere sentirse incomodo con madre, prefiere no verla. Se siente bien con su papá

Siente que padres están intentando mejorar la relación y comunicación entre ambos

Sueño: adecuado, sin pesadillas, lo percibe como reparador

Niega consumo de sustancias ni curiosidad por esta

Solo dif sensoriales a nivel auditivo en clases, le estresan cuando gritan, fines de semana le gusta estar en su casa en calma, le gustan actividades solitarias, refiere el disfruta estar en su casa. Sin dif sensoriales a nivel táctil o propioceptivo, olfativo ni visual. No se considera una persona estructurada, no le molesta salirse de las rutinas. Pareja desde hace 4 meses

Al realizar entrega de hipótesis dg se observa tensión entre los padres.

3. ANTECEDENTES PSIQUIÁTRICOS PERSONALES

- Diagnósticos previos: TDA, dif. Aprendizaje, se habría hecho despeje de TEA con neurología y se descarta (hicieron test no saben nombre). T. lenguaje estuvo en fonoaudiología a los 4 años, se descarta que haya sido por el TEC.
- Hospitalizaciones previas: a los 2 años por TEC (accidente auto)
- Tratamientos farmacológicos: en etapa escolar neoradix
- Psicoterapia previa: si, pero sin frecuencia adecuada (esporádica)
- Conductas autolesivas: pensamientos si pero no llega a concretarlo / ideación suicida: no

4. ANTECEDENTES MÉDICOS GENERALES

- Patologías médicas relevantes: sano, antecedente TEC a los 2 años, sin secuelas aparentes, hospitalizado 1 semana
- Tratamientos actuales: sin medicamentos
- Alergias: no

5. ANTECEDENTES FAMILIARES

- Antecedentes psiquiátricos familiares: madre actualmente en controles con psiquiatra según lo referido por ella por lo que está sucediendo con Santiago. Por línea materna antecedente de alzheimer.
- Contexto psicosocial relevante: Padres se separan el año 2017, aparentemente no en buenos términos. Santiago testigo discusiones frecuentes, actualmente vive con padre y hermana en Paine y no desea ver a la madre, refiere sentirse incómodo con esta.

6. EVALUACIÓN DEL ESTADO MENTAL

- Apariencia: constitución ectomorfa, acorde a edad cronológica, vestimenta e higiene adecuada, uñas pintadas negras
- Actitud: cooperador, respuestas breves impresiona desde la ansiedad
- Psicomotricidad: se observa normal
- Lenguaje: Notificativo, atingente, sin alteraciones en estructura. Respuestas breves, impresiona le cuesta profundizar en emociones
- Pensamiento: Sin alteraciones formales, niega delirios y niega alteraciones sensorio-perceptuales hoy. Contenido relacionado con dificultad en expresar sus emociones
- Ánimo impresiona aplanamiento afectivo, importante discordancia ideoaffectiva al hablar de conflicto y rechazo hacia ver a madre actualmente, relata eventos adversos en infancia sin conectar emocionalmente con estos.
- Contacto visual adecuado
- Juicio de realidad: conservado, no psicótico.
- Insight: no
- Ci: impresiona normal-bajo?

7. EVALUACIÓN DE RIESGO

- Riesgo suicida: actualmente sin ideación suicida, refiere ideas intermitentes sin llegar a planificación concreta, últimas en verano, nunca ha llegado a planificación o estructura de estas, se siente capaz de pedir ayuda, niega último mes ideas de querer morir.
- Factores de riesgo: eventos adversos en infancia: (separación padres, testigo vif entre padres verbal, historia de bullying en infancia, recuerdos de madre refiriendo que los iba a secuestrar al irse a vivir con padre), dificultad importante en reconocer sus propios estados emocionales y expresarlos, tiempo excesivo en videojuegos co riesgo de posible adicción y posible mecanismo de autorregulación actual
- Factores protectores: redes de apoyo presente (ambos padres), nivel cognitivo suficiente para psicoterapia, buena integración en grupo de pares (refiere tener buenos amigos), pareja actual, ausencia de consumo de sustancias o exposición a situaciones de riesgo, colaborador a posible proceso terapéutico.

8. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA (DSM-5 / CIE-11)

Diagnóstico principal:

- Obs Trauma complejo (eventos adversos en infancia no elaborados)
- T. depresivo

Diagnósticos secundarios:

- Disfunción familiar
- Obs T. vínculo con madre

9. PLAN TERAPÉUTICO

- Tratamiento farmacológico:
 - sertralina (sugiero altruline) $\frac{1}{4}$ por 5 días, luego $\frac{1}{2}$ -0-0
 - azymol 5 mg 1-0-0
- Intervenciones psicosociales:
 - psicoeducación a padres sobre síntomas posiblemente asociados a eventos adversos en infancia vividos como traumáticos que se presentan como sintoma actualmente a través de estados emocionales en donde busca autorregulación a través de ideas de autodaño
 - se psicoeduca en relación a rol de fármacos y que tratamiento principal sería la psicoterapia con periodicidad semanal y buena adherencia
 - se entregan herramientas de contención emocional y estrategias de regulación emocional en caso de reaparecer ideas de autodaño
 - Se entregan medidas de prevención suicidio y autodaño: guardar medicamentos bajo llave, ser administrados por adulto responsable, retirar objetos potencialmente peligrosos de su alcance
 - Se envía informe con plan de crisis para colegio
 - se indica que frente a ideación suicida se debe consultar en servicio de urgencia
- Derivaciones:
 - Se deriva a psicología (idealmente con enfoque en trauma y t.vincular) + evaluar necesidad de psicometría (antecedente de TEC)
 - control con psiquiatra en 3 semanas o SOS

10. SEGUIMIENTO

- Fecha próximo control: 3 semanas
- Red de apoyo: ambos padres
- Indicaciones a cuidadores:

-psicoeducación a padres sobre síntomas posiblemente asociados a eventos adversos en infancia vividos como traumáticos que se presentan como sintoma actualmente a través de estados emocionales en donde busca autorregulación a través de ideas de autodaño

-se psicoeduca en relación a rol de fármacos y que tratamiento principal sería la psicoterapia con periodicidad semanal y buena adherencia

-se entregan herramientas de contención emocional y estrategias de regulación emocional en caso de reaparecer ideas de autodaño

-Se entregan medidas de prevención suicidio y autodaño: guardar medicamentos bajo llave, ser administrados por adulto responsable, retirar objetos potencialmente peligrosos de su alcance

-Se envía informe con plan de crisis para colegio

-se indica que frente a ideación suicida o conducta autolesiva se debe consultar en servicio de urgencia

11. DATOS DEL PROFESIONAL

Nombre: Caterina Schiappacasse Arteaga

Especialidad: psiquiatra infanto juvenil

Registro profesional: 105595

Centro de atención: Psicoeduka Santiago

Fecha: 2 de mayo 2026

Control 27 de mayo de 2026

Atención vía online con ambos padres

Padre quien pasa más tiempo con él refiere que lo ha observado de mejor ánimo, nota que presenta mayor energía, por ejemplo con más entusiasmo para salir y no pasar tanto tiempo en su pieza. Primeros días sensación de cansancio con aripiprazol, siguen indicaciones de disminuir a mitad de dosis, con esto ceden las molestias. Asistiendo a colegio de manera normal, padre refiere que no ha manifestado ideas de autodaño o ideación suicida. Luego madre refiere que decide llevarlo a una psicóloga que ella conoce que trabaja con hipnosis.

A entrevista con Santiago solo: cooperador, impresionado ansioso, refiere ha estado bien, sin ideas de autodaño ni ideación suicida, refiriendo que desea el alta. Se psicoeduca con respecto a procesos de salud mental y que tratamiento debe mantenerse entre 3 y 6 meses. Se indaga en experiencia con psicóloga, no profundiza pero refiere que estuvo bien pero que no desea continuar yendo porque se siente bien. Al indagar más en sus emociones, tiende a responder sobre síntomas físicos relacionados al tratamiento: con primeros días mareos los que luego ceden. Tiende a respuestas concretas, refiere buen ánimo, niega preocupaciones o necesidad de ayuda a nivel familiar o emocional. Padre luego a solas refiere eventos que lo marcaron hace años, cuando llegaba de manera imprevista carabineros con madre a la casa.

Permanezco conectada con madre para indagar acerca de su propio estado de salud mental, refiere se encuentra en controles porque le ha afectado lo referido por Santiago. Acude los fin de semana a Paine pero es poco lo que comparten, refiere se dedica mas a cosas domésticas, que Santiago se encierra en su pieza. Luego refiere episodio de carabineros sucede porque padre vivía en una casa a la cual ella no podía acceder y quería ver a sus hijos. Madre refiere que a padre le cuesta poner límites con Santiago, existen pocas rutinas, y que al parecer él estaría de acuerdo con dejar de tener controles. Se informa a madre que no existe evidencia científica de hipnosis en población infanto juvenil y que Santiago requiere una psicóloga con experiencia en eventos adversos en infancia, terapia expresiva. Madre refiere que en colegio acude un neurólogo y Santiago es ingresado a PIE como TEA 1. En infancia ADOS-2 no sugerente, pero si en historia aparecen dificultades sensoriales, sociales, tendencia a estructura. Se sugiere a madre continuar con psicoterapia con Santiago con el enfoque sugerido. Madre duda de la adherencia al tratamiento.

Diagnóstico:

Trauma complejo

Disfunción familiar

TEA 1

Indicaciones

-altruline 50 mg ½-0-0

-azymol 5 mg ½-0-0

-psicoterapia en psicoeducación

-control en 2 meses